ER+预后好(好事)、HER2+预后差(坏事)四、分子亚型（ER、PR、*HER2*、Ki-67)反映肿瘤增殖活性

	ER/PR雌/孕激素受体	*HER2*表皮生长因子受体
Luminal A（管腔 A 型）	+	-
Luminal B（管腔 B 型）	+ 三阳性乳腺癌	+（Beyond）
HER2 过表达型	-	+
basal-like 基底样型（三阴性乳腺癌）	-	-

注意：**三阴性乳腺癌预后最差**（它不吃饭、不喝水都能活下来、生孩子能力还强）

雌激素是癌细胞要吃的饭,有了ER/PR(嘴巴)就可以吃饭,有了HER2就可以喝水,Ki-67反映肿瘤细胞生孩子能力

五、临床表现

1.最早最常见：肿块，**外上象限**多见，多**单**发、**无**痛、质**硬**、分界**不清**、**不易**推动 癌的一般规律

癌一般不痛,肝癌痛是因为癌侵犯到了肝包膜

骨头的某些肿瘤痛是因为会溶骨

纤维组织多　癌容易粘连

2.血性溢液；邻近乳头或乳晕的癌肿侵犯乳管→乳头凹陷



3.**皮肤**表现 淋巴水肿:丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病

①**凹陷（酒窝征）**：侵犯 Cooper/乳房悬**韧带** 一端连在皮肤上

②**水肿（橘皮样变）**：阻塞真皮内**淋巴管**

③卫星结节：广泛淋巴转移致淋巴液逆流使癌细胞侵犯大片皮肤

④粘连、恶臭溃疡、**红肿等炎症样（炎性乳癌）**、糜烂等湿疹样（Paget 病）

经椎旁静脉系统转移到骨

4.淋巴转移最早最常见；**早期**可有血道转移至骨、肺、肝等



六、检查

①**筛查：钼靶 X 线（毛刺、细小密集的泥沙样钙化）+超声（可观察血供）**

②金标准：活检（不宜切取部分活检）

③MRI、乳管内镜、溢液涂片、乳头糜烂部刮片

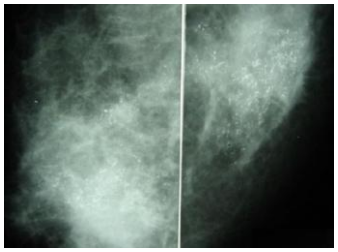
④CA153：疗效、预后、复发等（五年高考三年模拟忍辱负重）肿瘤标志物具有诊断价值:AFP、前列腺特异抗原

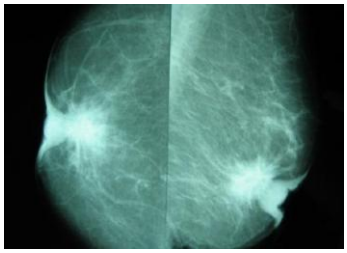
⑤抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes,*BRCA*）缺陷：可考虑预防性乳房全切术

⑥放射性核素骨扫描 **ECT**：显示乳腺癌骨转移灶（乳腺癌经椎旁静脉系统转移至**脊椎骨尤其椎弓根**可致腰背痛）

乳腺癌患者莫名其妙出现腰背部疼痛要做ECT







椎弓根血供丰富

区分结核/癌症:看是椎体破坏(如脊椎结核)还是椎弓根破坏(如脊椎转移瘤)